PROTOCOLLO 40

Trigger point del temporale

Ridurre il dolore miofasciale e il dolore riferito originato dal temporale

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Dolore miofasciale con riferito	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore riferito a tempia, sopracciglio e denti superiori
- ✓ Punto dolente che riproduce il dolore familiare
- ✓ Cefalea temporale associata

Controindicazioni e precauzioni

- ! Lesioni cutanee, infezioni o tumefazioni locali
- ! Terapia anticoagulante o fragilità vascolare: ridurre la pressione
- ! Sintomi neuropatici o red flags non indagate
- ! Sensibilizzazione marcata: iniziare con intensità minima

Posizionamento

Paziente: supino, capo appoggiato, mandibola rilassata.

Fisioterapista: alla testa del lettino.

Esecuzione passo dopo passo



Localizzazione

Palpa la fossa temporale nelle porzioni anteriore, media e posteriore e individua la banda tesa.



Compressione ischemica

Comprimi con i polpastrelli di indice e medio con pressione progressiva fino a dolore tollerabile (5 su 10).



Rilascio

Mantieni finché il dolore si riduce, poi rilascia lentamente.



Allungamento

Termina con un allungamento attivo dolce del muscolo.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Pressione	fino a dolore 5 su 10
Tenuta	60 a 90 secondi
Ripetizioni	2 o 3 per punto

Criteri di rivalutazione

DOLORE ALLA PALPAZIONE
____ / 10
sul punto trattato

APERTURA MASSIMA
____ mm
con calibro

DOLORE RIFERITO
Sì / No
riproduzione del dolore familiare

Punti chiave

- ✓ Il dolore deve ridursi durante la tenuta
- ✓ Chiedi sempre se il dolore è familiare
- ✓ Associa esercizio attivo

Errori da evitare

- ! Pressione eccessiva o improvvisa
- ! Pressione sul decorso di vasi o nervi
- ! Trattare troppi punti nella stessa seduta

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Automassaggio del temporale	Movimenti circolari lenti sulla tempia	60 secondi per lato, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Il temporale è spesso coinvolto nella cefalea attribuita a DTM.

Bibliografia essenziale

1. Schiffman E. et al. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for clinical and research applications. J Oral Facial Pain Headache. 2014;28(1):6–27.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.